

FOTO VAN LAIA ABRIL

DE NORM ALS WAPEN

OVER MASS HYSTERIA EN
NORMALITEIT ALS CONTROLE

RENS KOSTER

MINOR AV DESIGN
ARTISTIEKE VISIE ESSAY

INLEIDING

Voor een opdracht moesten we een fotocollectie uit een boek kiezen. Wij kozen On Mass Hysteria van Laia Abril. Niet omdat we al wisten wat we ermee wilde, maar omdat we de beelden er cool uit vonden zien. Abril laat zien hoe groepen vrouwen door de geschiedenis heen collectief lichamelijke en emotionele klachten ervoeren, en hoe de maatschappij daar steeds op dezelfde manier op reageerde: door ze weg te zetten als gek, overdreven of hysterisch. Deze beelden bleven hangen bij mij.

Vanuit die fotocollectie hebben wij als groep zelf besloten om verder te gaan met de medische standaard in de zorg als onderwerp voor ons installatieproject. De link zat in die steeds terugkerende reactie op vrouwen die klagen: je wordt niet geloofd. Dat patroon zag ik in Abrils werk, en ik zag het terug in hoe de zorg omgaat met vrouwen vandaag de dag.

Dit essay staat los van dat project en heb ik geschreven vanuit mijn eigen interesse in wat Abril eigenlijk laat zien: de vraag wie bepaalt wat normaal is, en wat er gebeurt met mensen die daar niet in passen.



Laia Abril, On Mass Hysteria (2024)

DE ONDERZOEKSVRAAG:

In hoeverre functioneert het concept van mass hysteria als mechanisme van sociale controle, waarmee afwijkend gedrag, in het bijzonder bij vrouwen, wordt genormaliseerd of gesanctioneerd, en hoe vertaalt dit zich naar de hedendaagse medische praktijk?



Om die vraag te beantwoorden kijk ik eerst naar de geschiedenis van hysterie als diagnose, daarna naar hoe normaliteit als controlemechanisme werkt via de theorie van Foucault, dan naar de relatie tussen hysterie en politieke controle over vrouwen, dan naar een historisch en modern voorbeeld, dan naar de doorwerking in de hedendaagse zorg, en tot slot reflecteer ik op hoe dit mijn keuzes als ontwerper heeft beïnvloed.

HYSTERIE ALS DIAGNOSE

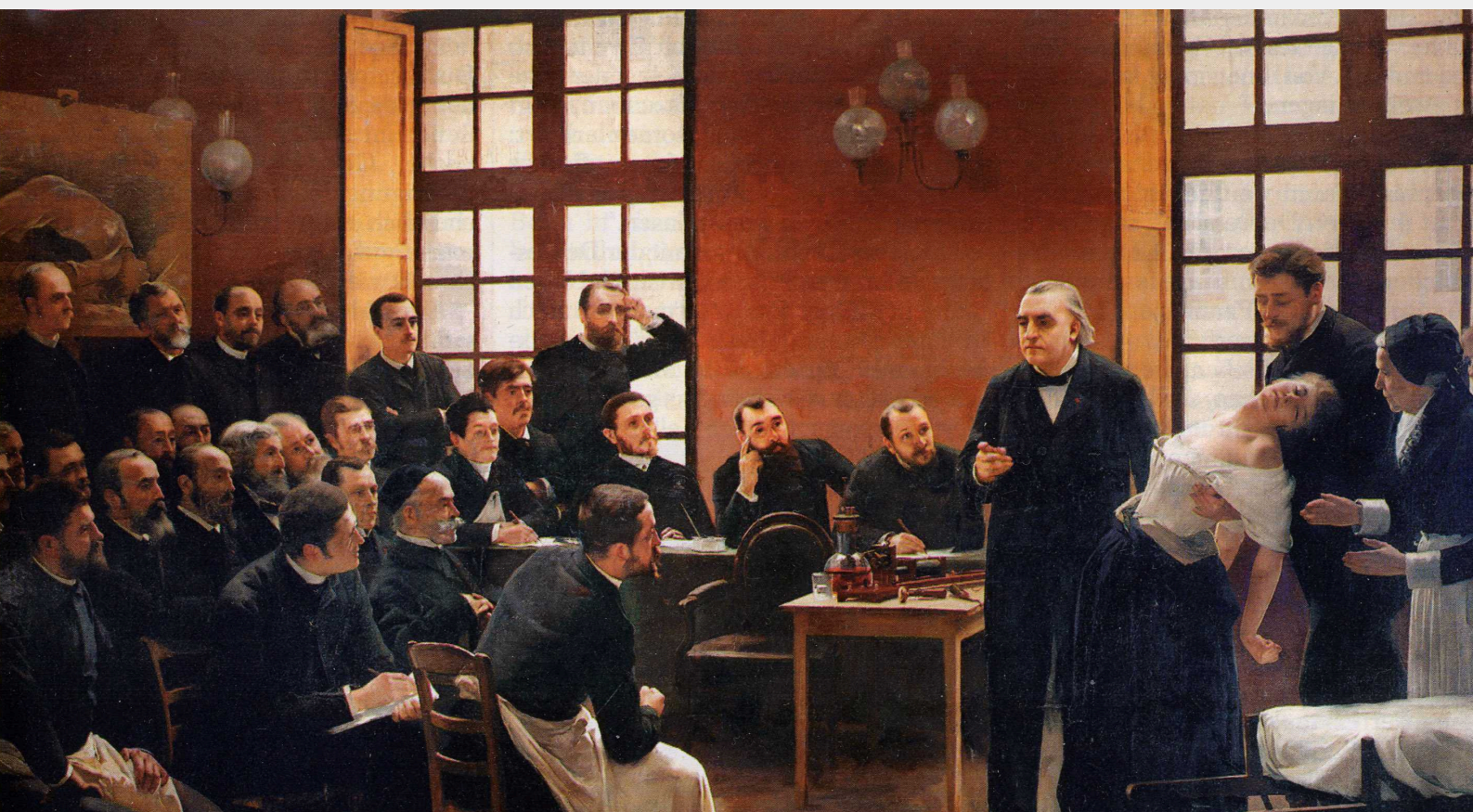
Het woord histerie komt van het Griekse woord voor baarmoeder: hystera. Hippocrates geloofde al in de vijfde eeuw voor Christus dat de baarmoeder door het lichaam van een vrouw kon bewegen en daardoor allerlei klachten kon veroorzaken. Elke afwijking van verwacht gedrag kon zo worden teruggeleid naar dat ene orgaan. Dat klinkt belachelijk, maar dit was voor eeuwen de medische consensus (Mental Floss, 2026).

Hysterie is daarmee het eerste mentale ziektebeeld dat uitsluitend aan vrouwen werd toegeschreven, al beschreven in het tweede millennium voor Christus en tot aan Freud beschouwd als een puur vrouwelijke aandoening (PMC, 2012).

De grote bloeiperiode van de hysterische diagnose was de negentiende eeuw, en het middelpunt was het Salpêtrière ziekenhuis in Parijs. Neuroloog Jean-Martin Charcot organiseerde daar wekelijkse publieke lezingen waarbij vrouwelijke patiënten onder hypnose werden gebracht en hun symptomen werden gedemonstreerd voor een publiek van artsen, studenten en nieuwsgierige burgers. Wat als wetenschap werd gepresenteerd, leek in de praktijk veel meer op theater (History Blog, 2021).

Tijdens mijn research stuitte ik op een schilderij dat precies dat laat zien. Une leçon clinique à la Salpêtrière (1887) van André Brouillet toont Charcot die voor een zaal vol mannen staat, terwijl een vrouw achter hem bewusteloos achteroverleunt. Ze wordt opgevangen door een assistent, maar Charcot kijkt haar niet aan, hij wijst naar haar alsof ze een anatomisch model is. De zaal kijkt toe. Niemand doet iets.

André Brouillet, Une leçon clinique à la Salpêtrière (1887)





Wat daarin opvalt is wie er eigenlijk in dat ziekenhuis terechtkwam. Veel vrouwen die als hysterisch werden gediagnosticeerd, hadden een voorgeschiedenis van armoede, misbruik en trauma. Maar hun klachten werden niet serieus genomen als reacties op een moeilijk leven. Ze werden gezien als bewijs van een zwakke geest. Een veertienjarig meisje genaamd Augustine werd door een arts omschreven als de ideale hysterica, puur omdat ze rebels was en te veel aandacht besteedde aan hoe ze eruitzag (Missoulain, 2011).

De diagnose was geen neutrale medische observatie, maar een oordeel. Feminist scholar Elaine Showalter formuleerde het goed: de hysterische vrouw werd niet zozeer genezen als wel het zwijgen opgelegd (Utterlyinteresting, 2025). De diagnose werkte als een manier om vrouwen die te veel klaagden, te weinig gehoorzaamden of gewoon niet pasten buiten het gesprek te houden. Psychiatrie was in die zin ook gewoon een politiek instrument.

NORMALITEIT ALS CONTROLEMECHANISME

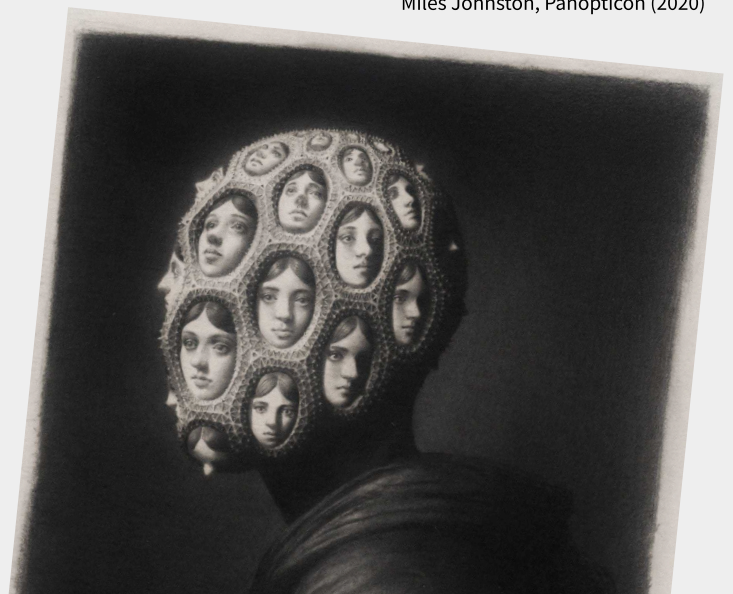
Om te begrijpen waarom de hysteriediagnose zo effectief werkte als controle, is het werk van Michel Foucault heel nuttig. Foucault betoogde in onder andere *Discipline and Punish* (1975) dat macht in de moderne samenleving niet alleen werkt via wetten en straffen, maar via normalisering. Dat betekent: je stelt een ideaal van normaal gedrag vast, en alles wat daarbuiten valt wordt gecategoriseerd als afwijkend of ziek (Internet Encyclopedia of Philosophy, z.d.).

Het slimme aan normalisering is dat het niemand hoeft te dwingen. Als iedereen weet wat normaal is, gaan mensen zichzelf vanzelf corrigeren. Wie toch afwijkt, voelt dat meteen: je wordt bekeken, beoordeeld, gecategoriseerd. Foucault noemde dit disciplinaire macht. Je bent normaal of je bent deviant. Je gedraagt je of je bent hysterisch (Wikipedia, Normalization, z.d.).

Foucault gebruikte het Panopticon als metafoor: een gevangenisontwerp van Jeremy Bentham uit 1787 waarbij een bewaker vanuit een centrale toren alle cellen kan zien, maar de gevangenen nooit weten wanneer ze bekeken worden. Het gevolg: ze gedragen zich altijd alsof het zo is. Er hoeft niemand te kijken. De controle zit in het idee dat iemand kán kijken.

Een tekening die mij aansprak was van Miles Johnston - "Panopticon". In deze tekening zie je een hoofd waarin meerdere vrouwengezichten aanwezig zijn. Deze gezichten lijken constant bekeken te worden door het centrale karakter. De vrouwen binnen het hoofd lijken geen controle te hebben over hoe ze worden waargenomen, wat aansluit bij het idee dat vrouwenervaringen vaak door externe partijen worden geïnterpreteerd en gelabeld.

Miles Johnston, Panopticon (2020)





NORMALITEIT ALS CONTROLEMECHANISME

Dat is precies wat er gebeurde met vrouwen die niet pasten binnen het negentiende-eeuwse ideaalbeeld van de rustige, gehoorzame en huiselijke vrouw. Hun gedrag en emoties werden voortdurend beoordeeld door een systeem dat bepaalde wat als normaal werd gezien. Wanneer een vrouw klaagde, grenzen stelde of sterke emoties toonde, werd dat niet gezien als een begrijpelijke reactie op haar omstandigheden, maar als een teken van afwijking. Haar ervaringen werden dus, net als de gezichten in *Panopticon*, van buitenaf geïnterpreteerd en gelabeld.

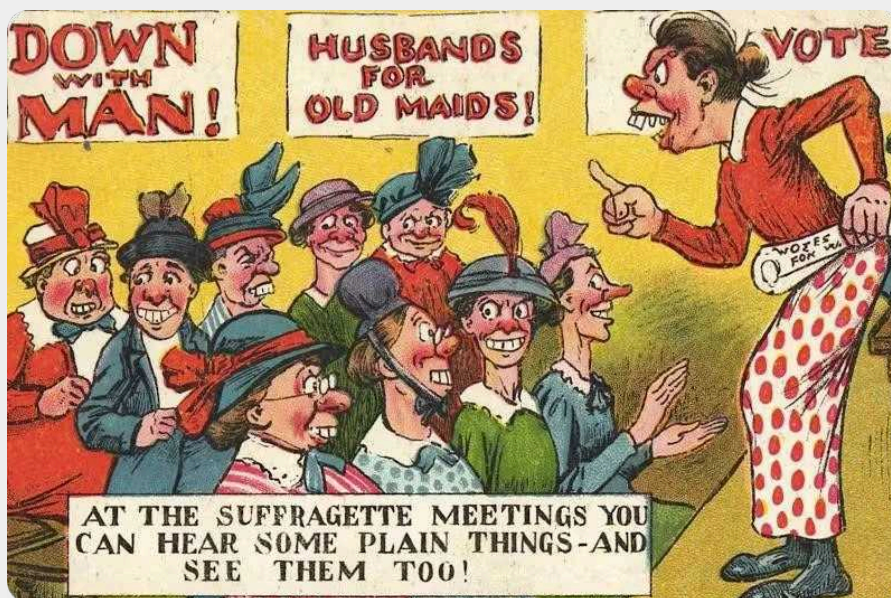
HET VROUWELIJKE LICHAAM ALS POLITIEK OBJECT

De bloeiperiode van de hysteriediagnose, de tweede helft van de negentiende eeuw, viel niet toevallig samen met de opkomst van de vrouwenrechtenbeweging. In dezelfde decennia dat vrouwen steeds luider eisten mee te mogen doen aan het politieke en maatschappelijke leven, werd de hysteriediagnose steeds breder ingezet. Dat is geen toeval.

Vrouwen werden in die tijd beschouwd als biologisch ongeschikt voor politiek, omdat hun lichaam hen nu eenmaal kwetsbaar maakte voor hysterie. De suffragettes, de vrouwen die vochten voor stemrecht, werden door de pers en de overheid direct in verband gebracht met hysterie en mentale instabiliteit. Anti-suffrage propagandacartoons declareerden de geestelijke onstabieleit van deze vrouwen, omdat het veel eenvoudiger was om hysterie te tolereren dan verandering toe te staan (Virginia Commonwealth University, z.d.).

Die cartoons heb ik ook opgezocht. Wat opvalt is hoe consistent het beeld is: de vrouw die eist, wordt altijd afgebeeld als schreeuwend, ongecontroleerd, lelijk. Nooit als iemand met een argument.

Anoniem, anti-suffrage propagandaprent, ca. 1910



De boodschap is glashelder zonder dat het woord "hysterisch" valt: haar eis is geen politiek standpunt, het is een symptoom. De diagnose werd zo een politiek wapen: wie eist, is gek. Wie gek is, heeft geen stem (British Psychological Society, 2026).

MASS HYSTERIA ALS COLLECTIEF FENOMEEN

Tot nu toe had ik het vooral over histerie als diagnose voor individuele vrouwen. Maar het fenomeen heeft ook een collectieve kant, en die is net zo interessant. Het bekendste historische voorbeeld zijn de heksenprocessen in Salem, Massachusetts, in 1692 en 1693. Wat begon met een paar meisjes die vreemde lichamelijke symptomen vertoonden, groeide uit tot een collectieve paniek die eindigde in twintig executies en de dood van vijf andere inwoners (FindZebra, z.d.).

Dit is een voorbeeld van hoe sociale druk, religieuze angst en groepsdynamiek kunnen leiden tot collectief gedrag dat van buitenaf absurd lijkt maar van binnenuit logisch aanvoelt. Socioloog Stanley Cohen noemde dit een moral panic: een situatie waarin een vermeende bedreiging van sociale waarden zo sterk wordt uitvergroot dat er echte schade ontstaat (Psychology Town, 2026).

Ik stuitte tijdens de research op het schilderij *Examination of a Witch* (1853) van Thompkins H. Matteson. Het toont een kring van mensen die een vrouw omringen en onderzoeken: haar kleding wordt opengetrokken, ze wordt bekeken. Ze kijkt niet terug.

Examination of a Witch, Thompkins H. Matteson (1853)



MASS HYSTERIA ALS COLLECTIEF FENOMEEN

Wat Salem zo relevant maakt is de vraag wie er als heks of als hysterisch werd aangewezen, en waarom. De beschuldigten waren vrijwel uitsluitend vrouwen, en de beschuldigers waren meisjes zonder macht in de gemeenschap. De hysterie werkte hier als een manier om de sociale orde te handhaven: wie niet paste, wie te eigenzinnig was of te veel bezat, werd aangewezen als afwijkend en uitgeschakeld. De norm bepaalde wie gevaarlijk was. En die norm was mannelijk, religieus en collectief.

Dat patroon is niet iets van vroeger. In 2021 en 2022 ontwikkelden tienduizenden meisjes wereldwijd plotseling tics: onvrijwillige bewegingen en vocale uitbarstingen die leken op het Tourette-syndroom. Ze kwamen niet uit dezelfde stad of school. Ze deelden wel allemaal dezelfde app: TikTok. Onderzoek wees uit dat 68 procent van de getroffen meisjes aangaf hun tics te hebben opgedaan via TikTok-video's van mensen met het Tourette-syndroom (Newport Academy, 2022).

Dit fenomeen, door onderzoekers omschreven als 'mass social media-induced illness', laat zien dat mass hysteria niet verdwenen is, maar een nieuwe vorm heeft gekregen (PubMed, 2021). En ook hier zijn het vrijwel uitsluitend meisjes die getroffen worden. Dat is geen toeval. Het zijn meisjes die opgroeien in een wereld vol prestatiedruk, sociale verwachtingen en beperkte ruimte voor emotioneel ongemak. Wat Salem en TikTok verbindt is dat een groep mensen, voornamelijk vrouwen en meisjes, die buiten de verwachte norm vallen en daarvoor worden gesanctioneerd of gediagnosticeerd.

DE DOORWERKING IN DE HEDENDAAGSE ZORG

Officieel bestaat de hysterische vrouw niet meer. Hysterie is in 1980 uit het diagnostisch handboek DSM gehaald. Maar de onderliggende logica, de neiging om klachten van vrouwen af te doen als emotioneel of overdreven, is gebleven. De vorm is veranderd, de structuur niet. Auteur Janet Wirth-Cauchon stelde dat het label 'borderline' vandaag de dag dezelfde functie vervult als 'hysterie' in de late negentiende en vroeg twintigste eeuw: een diagnose die wordt toegepast op vrouwen wier gedrag als afwijkend wordt beschouwd (Talkspace, 2022).

Vrouwen wachten gemiddeld vier jaar langer op een correcte diagnose dan mannen (MARI Research, 2026). Dat heeft deels te maken met het feit dat medisch onderzoek decennialang vooral op mannelijke proefpersonen werd uitgevoerd. De FDA sloot vrouwen met een mogelijke kinderwens in 1977 officieel uit van vroege fases van klinisch onderzoek, en pas in 1993 werd het verplicht om vrouwen op te nemen in door de overheid gefinancierd onderzoek (NIH, 2024).

In de tussentijd zijn er generaties artsen opgeleid met kennis die grotendeels gebaseerd is op het mannelijke lichaam als standaard. Het gevolg is dat symptoombeelden in leerboeken het mannelijke patroon beschrijven. Een hartaanval heeft pijn op de borst en uitstraling naar de linkerarm. Maar vrouwen die een hartaanval krijgen, ervaren vaker misselijkheid, kaakpijn en extreme vermoeidheid, zonder de klassieke borstkaspijn. Omdat hun klachten niet overeenkomen met het standaardbeeld, worden ze vaker over het hoofd gezien of afgedaan als stress of een paniekaanval (MARI Research, 2026). Bij endometriose duurt het gemiddeld tot tien jaar voor de juiste diagnose wordt gesteld, mede omdat de klachten als overdreven of onverklaarbaar worden beschouwd (Talkspace, 2022).

Dit is geen fout van individuele artsen. Het is een structureel probleem dat geworteld is in precies dezelfde logica als de hysterische vrouw van de negentiende eeuw: het vrouwelijke lichaam is de afwijking terwijl het mannelijke lichaam de norm is. Foucaults normalisering is hier volledig van toepassing: de medische standaard is geen neutrale beschrijving van de werkelijkheid. Het is een machtsinstrument dat bepaalt wie gezien wordt en wie niet. En dat instrument is, net als de hysteriediagnose, niet neutraal.

REFLECTIE: MASS HYSTERIA ALS ONTWERPER

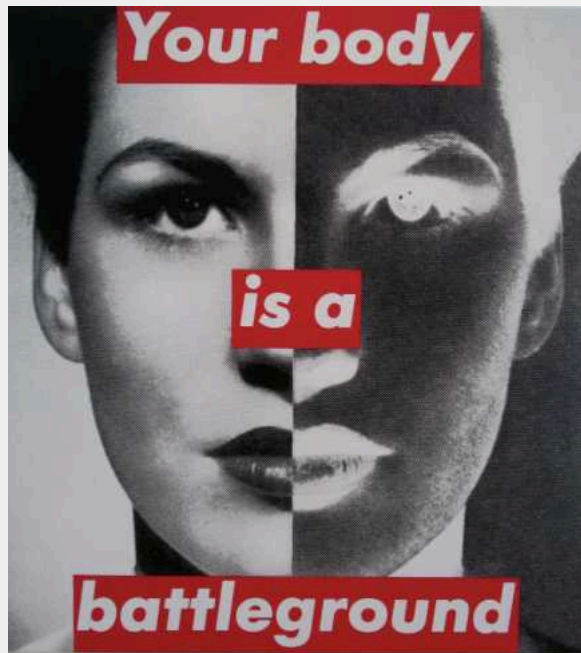
Ik ben geen vrouw en ik ben dit onderwerp binnengekomen via een foto in een boek, niet via persoonlijke ervaring. Maar juist dat heeft mij iets duidelijk gemaakt wat ik anders misschien niet zo had gezien: hoe vanzelfsprekend de norm is voor mensen die er gewoon inpassen.

De fotoserie van Abril werkt omdat ze je dwingt te kijken naar iets wat je liever niet ziet. Ze maakt het patroon zichtbaar zonder het uit te leggen. En dat is precies wat mij als ontwerper interesseert: hoe maak je iets onzichtbaar zichtbaar, zonder dat je het hoeft toe te lichten? Dat is ook de reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen voor dit essay. Niet alleen omdat het aansloot bij ons project, maar omdat Abrils werk mij liet zien dat de keuze voor een onderwerp al een politieke keuze is.

Een kunstenaar die ik tegenkwam en die op een vergelijkbare manier werkt is Barbara Kruger. Haar bekendste werk, *Untitled (Your body is a battleground)* uit 1989, is een zeefdruk met een vrouwegezicht, gesplitst in positief en negatief, met de tekst "Your body is a battleground" er dwars doorheen. Ze gebruikte het als affiche voor een mars voor reproductieve rechten.

Ze gebruikt de taal van reclame: strakke typografie, zwart-wit, korte tekst, maar dan om het systeem aan te vallen dat die taal normaal gebruikt om je iets te verkopen. Als ontwerper vind ik dat interessant, want het laat zien dat de keuze voor een vorm nooit neutraal is. Hoe je iets zegt, is ook een standpunt.

Barbara Kruger, *Untitled (Your body is a battleground)* (1989)



REFLECTIE: MASS HYSTERIA ALS ONTWERPER

Dat heeft ook direct invloed gehad op hoe wij ons installatieproject hebben vormgegeven. We willen twee dingen bereiken: het probleem zichtbaar maken voor de gemiddelde bezoeker die er nog nooit over heeft nagedacht, en awareness creëren bij vrouwen dat een eerste diagnose niet altijd de juiste is. Dat tweede vind ik persoonlijk het belangrijkste. Want de kennis dat jouw klachten misschien niet passen in het standaardbeeld, en dat je dus door mag vragen, kan echt iets veranderen. Niet in het systeem meteen, maar wel in hoe iemand de volgende doktersafspraken ingaat.

Dat is waarom we hebben gekozen voor een installatie waarbij de bezoeker zelf actief iets moet doen. Je leest het niet, je ervaart het. Je loopt vast. Je snapt niet waarom het niet klopt. En dan pas begrijp je het. Dat is wat Abril ook doet met haar beelden: ze laat je niet buiten staan, ze trekt je erin. En precies dat gevoel, van even niet weten hoe het zit, is de boodschap.

Mass hysteria interesseert mij omdat het laat zien dat de grens tussen normaal en gek nooit neutraal is. Het is altijd een keuze van wie de macht heeft om te definiëren. En in een samenleving die zichzelf graag als objectief en wetenschappelijk beschouwt, is dat een ongemakkelijke waarheid. Juist daarom vind ik het belangrijk dat er mensen zijn, fotografen, schrijvers, ontwerpers, die dat blijven benoemen.

CONCLUSIE

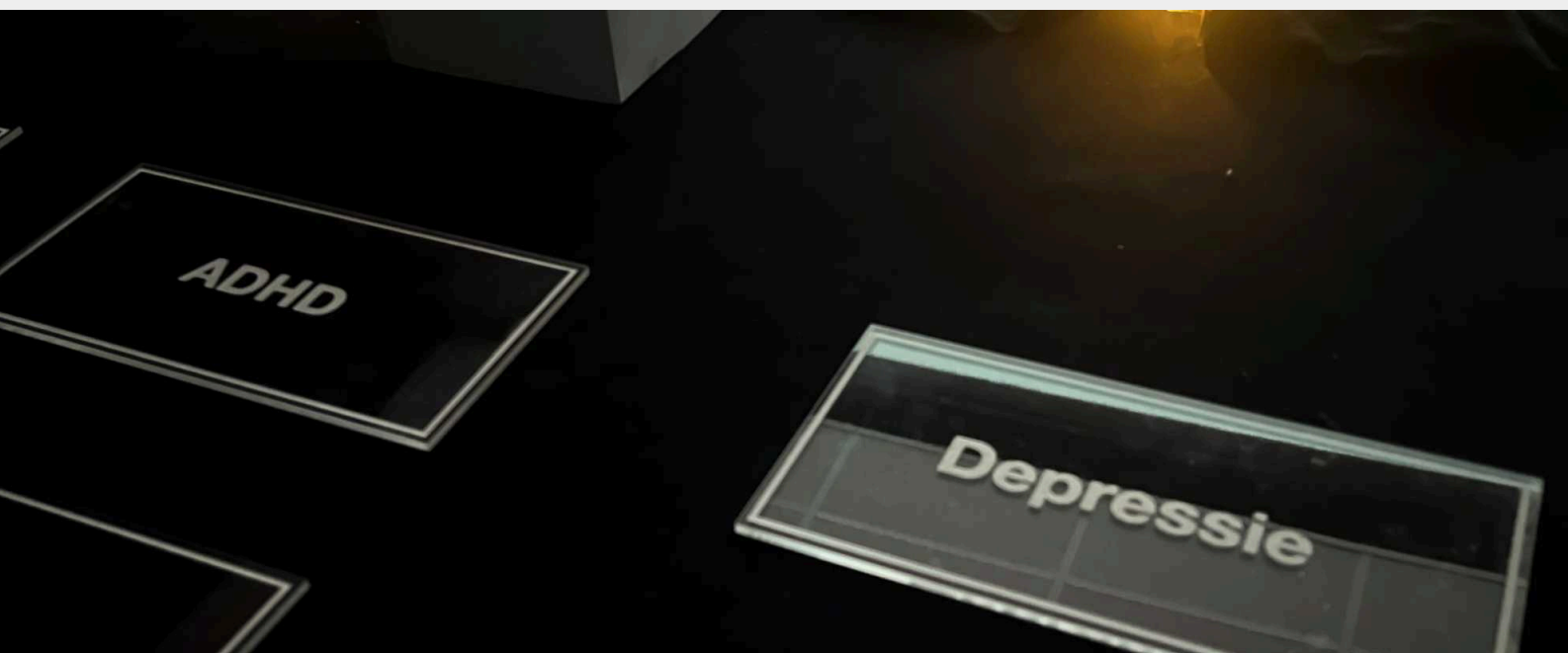
De onderzoeksvraag was: in hoeverre functioneert het concept van mass hysteria als mechanisme van sociale controle, waarmee afwijkend gedrag, in het bijzonder bij vrouwen, wordt genormaliseerd of gesanctioneerd, en hoe vertaalt dit zich naar de hedendaagse medische praktijk?

Het antwoord is dat mass hysteria historisch niet alleen een medische diagnose was, maar een instrument van macht. Via het vaststellen van de norm werd bepaald wie gezien werd en wie niet. Vrouwen die buiten die norm vielen, werden gesanctioneerd: opgesloten, genegeerd, het zwijgen opgelegd. Dat gold voor de vrouwen in het Salpêtrière, voor de suffragettes die als hysterisch werden weggezet, voor de meisjes in Salem, en voor de tieners met TikTok-tics. De context verandert steeds, de structuur niet.

Die logica is niet verdwenen. Ze heeft alleen een nieuwe vorm aangenomen in de medische standaard die gebaseerd is op het mannelijke lichaam, waarbinnen vrouwen structureel buiten beeld vallen. De vier jaar langere wachttijd op een diagnose is geen toeval. Het is de erfenis van eeuwen normstelling die het vrouwelijke lichaam als uitzondering beschouwde.

Wat mij daarin blijft raken, is dat dit patroon al zo lang zichtbaar is, in de geschiedenis, in de literatuur, in de kunst, en toch zo weinig veranderd is. Abril laat dat zien in haar fotoserie, en ik denk dat dat precies de reden is waarom die beelden bleven hangen.

Ons installatieproject probeert hetzelfde te doen op een andere manier. Door de bezoeker zelf te laten vastlopen in een systeem van onvolledige informatie, hopen we twee dingen te bereiken: het probleem zichtbaar maken voor mensen die er nooit over hebben nagedacht, en vrouwen het besef meegeven dat een eerste diagnose niet altijd de juiste hoeft te zijn. Dat je mag doorvragen. Dat twijfel geen zwakte is, maar soms gewoon de juiste reactie op een systeem dat jou niet volledig ziet.



BRONNENLIJST

Tekstuele bronnen

British Psychological Society. (2026, februari 4). Hysteria: a historical mirror in the misogyny of medicine? <https://www.bps.org.uk/psychologist/hysteria-historical-mirror-misogyny-medicine>

FindZebra. (z.d.). List of mass hysteria cases. <https://www.findzebra.com/details/A05QP8g-list-of-mass-hysteria-cases>

Internet Encyclopedia of Philosophy. (z.d.). Foucault, Michel: Feminism. <https://iep.utm.edu/foucfem/>

JSTOR Daily. (2019, juni 20). The racialized history of hysteria. <https://daily.jstor.org/the-racialized-history-of-hysteria/>

MARI Research. (2026, februari 20). Impact of misdiagnosis in women's health conditions. <https://mariresearch.com/impact-of-misdiagnosis-in-womens-health-conditions/>

Missouliau. (2011). Putting hysteria diagnosis to test. https://missouliau.com/entertainment/books-and-literature/putting-hysteria-diagnosis-to-test-author-researches-19th-century-medicines-treatment-of-women/article_34cec642-b499-11e0-90a7-001cc4c03286.html

National Institutes of Health. (2024). History of women's participation in clinical research. <https://orwh.od.nih.gov/toolkit/recruitment/history>

Newport Academy. (2022, juni 10). Why so many teen girls are experiencing TikTok tics. https://www.newportacademy.com/resources/mental-health/tiktok_tics/

PBS SoCal / Artbound. (2022, februari 8). A history of hysteria in art, film, and literature. <https://www.pbssocal.org/shows/artbound/a-history-of-hysteria-in-art-film-and-literature>

PMC / National Library of Medicine. (2012). Women and hysteria in the history of mental health. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3480686/>

BRONNENLIJST

PubMed. (2021, juli 1). Tics and TikTok: Functional tics spread through social media. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34765689/>

Psychology Town. (2026, maart 3). Understanding collective hysteria. <https://psychology.town/social/collective-hysteria-psychological-contagion-groups/>

Talkspace. (2022, november 10). The history of hysteria: Sexism in diagnosis. <https://www.talkspace.com/blog/history-hysteria-sexism-diagnosis/>

Utterlyinteresting. (2025, oktober 30). The Salpêtrière Hospital. <https://www.utterlyinteresting.com/post/the-salp%C3%AAtre-hospital-the-19th-century-parisian-asylum-that-shaped-modern-medicine-and-misunders>

Virginia Commonwealth University. (z.d.). Hysteria and the suffrage movement. <https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4744&context=etd>

Wikipedia. (z.d.). Normalization (sociology). [https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization_\(sociology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization_(sociology))

Afbeeldingen en kunstwerken

Abril, L. (2022). On Mass Hysteria [fotoboek]. Dewi Lewis Publishing.

Anoniem. (ca. 1910). Anti-suffrage propagandaprent [illustratie]. Bron: Virginia Commonwealth University collectie.

Brouillet, A. (1887). Une leçon clinique à la Salpêtrière [schilderij]. Université Paris Descartes, Parijs.

Johnston, M. (z.d.). Panopticon [grafiet op papier]. Beinart Gallery. <https://beinart.org/products/miles-johnston-panopticon-graphite-on-paper>

Kruger, B. (1989). Untitled (Your body is a battleground) [zeefdruk]. The Broad, Los Angeles.

Matteson, T.H. (1853). Examination of a Witch [schilderij]. Peabody Essex Museum, Salem.